

Pancreatite aguda · Atlanta e conduta

Diagnóstico: dor típica + lipase/amilase "e3× + imagem se dúvida. Classifique leve/moderadamente grave/grave (Atlanta) e trate suporte, causa biliar e necrose infectada com critério.

Atlanta — ideia rápida

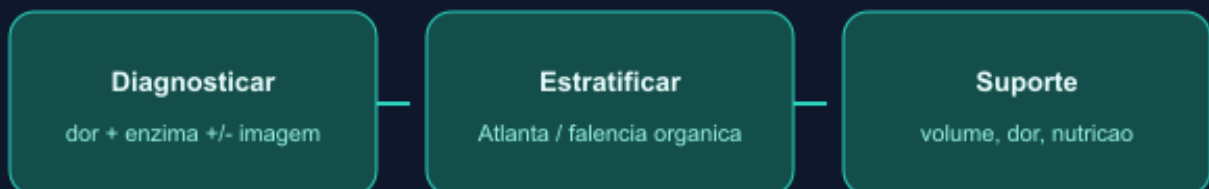
Dica - Atlanta — ideia rápida

Leve: sem falência orgânica nem complicação local. Moderadamente grave: falência transitória (<48 h) ou complicação local. Grave: falência persistente "e48 h.

Fluxo: critérios diagnósticos !' gravidade/órgãos !' volume + nutrição + causa (cálculo/álcool).

Pancreatite aguda

Diagnosticar -> estratificar -> suporte



Conduta inicial

- Volume generoso com cristaloides e reavaliação hemodinâmica/diurese
- Analgesia; oxigenação; corrigir eletrólitos e glicemia
- Nutrição enteral precoce quando tolerar — evitar jejum prolongado 'por protocolo'
- USG de abdome para litíase; CPRE se colangite / obstrução biliar persistente

Imagem e infecção

Situação | Conduta

Diagnóstico claro, leve | TC precoce não obrigatória

Dúvida / gravidade / falha | TC com contraste (idealmente >72 h se necrose)

Necrose infectada | ATB + drenagem step-up; cirurgia tardia se preciso

Colecistolitíase etiológica | Colecistectomia na mesma internação se leve

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Antibiótico profilático de rotina na pancreatite estéril não está indicado. Reserve ATB para infecção documentada/suspeita forte (necrose infectada, colangite).

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1